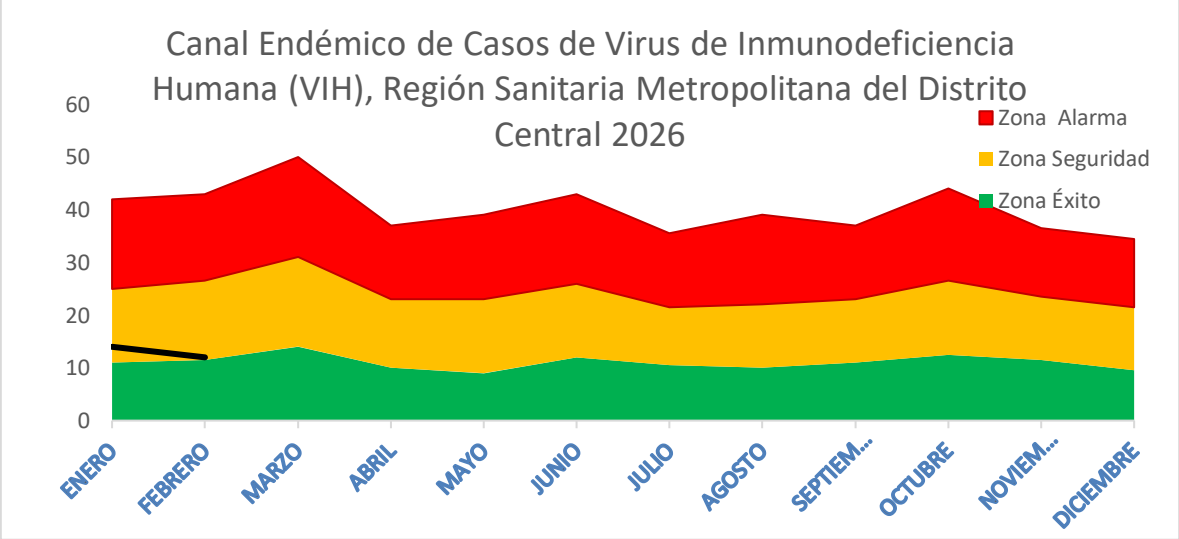
Situación epidemiológica de VIH en la RSM-DC

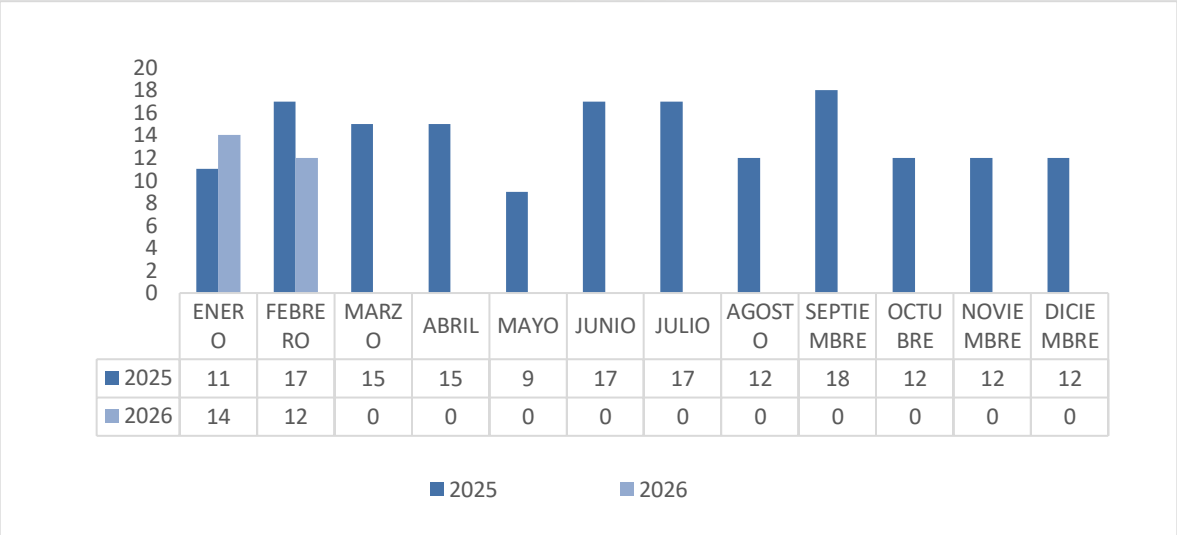
Gráfico 1:



Fuente: Base de datos EPI INFO/AGI RSM DC.

El canal endémico de casos de VIH para la Región Sanitaria Metropolitana del Distrito Central, construido con datos históricos del período 2019–2025 y comparado con la notificación acumulada hasta febrero de 2026, el cual se utiliza para la vigilancia programática, muestra que el comportamiento de los casos se mantiene dentro de los límites esperados, ubicándose en la zona de seguridad al inicio del año y evidenciando una disminución en febrero que incluso se aproxima a la zona de éxito; no se observa un incremento inusual o comportamiento epidémico de la infección por VIH en el MDC

Gráfico 2. Casos de VIH positivos notificados por mes en la RSM-DC 2025-2026



	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2025	11	17	15	15	9	17	17	12	18	12	12	12
2026	14	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

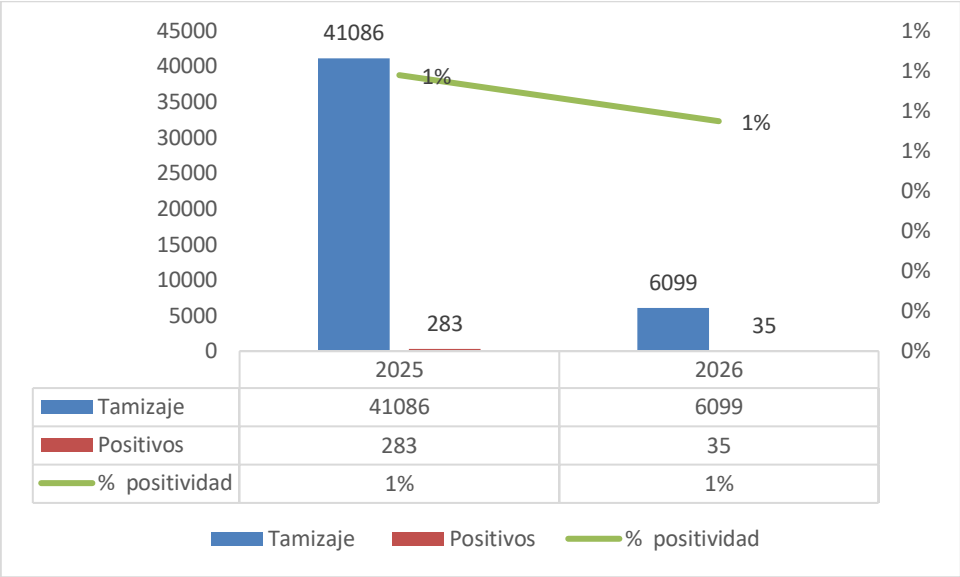
Fuente: Base de datos VIH-UVS

En enero, febrero y marzo del 2025 se registraron 43 casos, mientras que en el mismo período del 2026 se diagnosticaron 26, lo que representa una disminución del 40 % en comparación con el año anterior.

La prevalencia de VIH/SIDA en el 2025 fue de 12 casos 100,000 habitantes.

En el 2026 hasta el mes de febrero es de 2 casos $(\frac{26}{1372705})X100{,}000\ hab.$

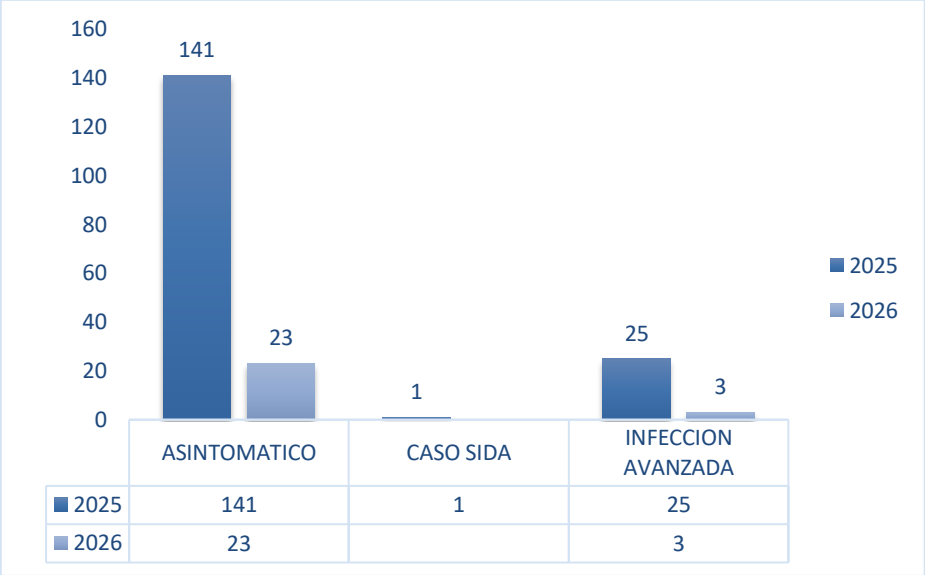
Gráfico 3. Positividad del tamizaje VIH positivos en la RSM-DC 2025-2026



Fuente: Base de datos USLAB

Durante el año 2025 se realizaron 41,086 pruebas de tamizaje para VIH, de las cuales 283 resultaron positivas, mientras que en 2026 (considerando el período enero-febrero) se registran 6,099 pruebas realizadas con 35 resultados positivos. En ambos períodos la positividad se mantiene alrededor del 1%, lo que indica que la proporción de casos detectados en relación con el número de pruebas realizadas se ha mantenido estable.

Gráfico 4. Clasificación de la enfermedad según Estadio Clínico RSM-DC AÑO 2025-2026



Fuente: Base de datos VIH-AGI-UVS

En el año 2025 se han notificado 167 casos nuevos, 84% (141) en estadio asintomático, 15% (25) casos de infección avanzada, 1% (1) casos de caso SIDA.

Y para el año 2026 se han notificado 26 casos nuevos, 88% (23) en estadio asintomático, 12% (3) casos de infección avanzada.

Tabla 1. Distribución de casos VIH según grupos de edad, RSM-DC año 2025-2026

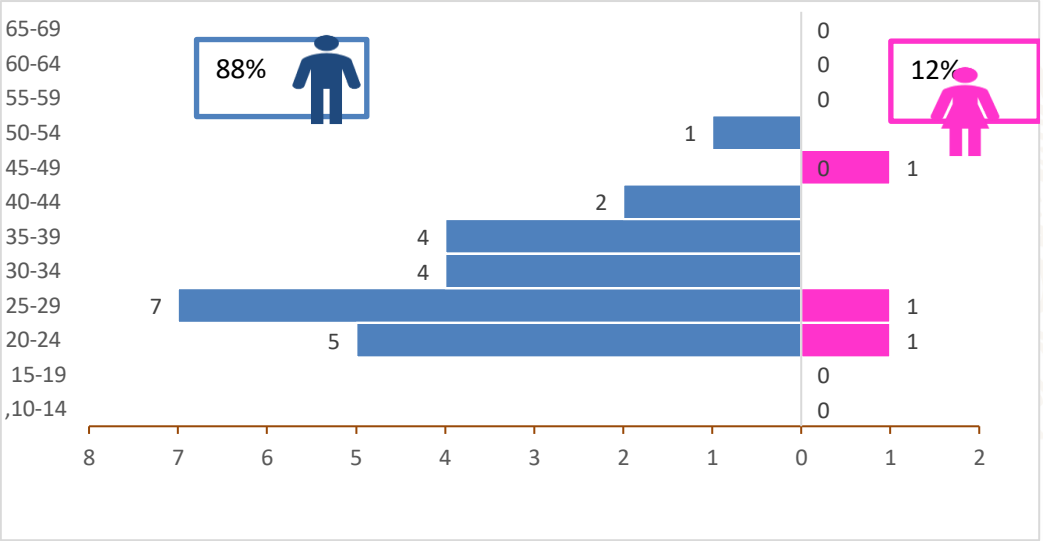
Rango de Edad	2025	2026
20-29 AÑOS	57	14
30-39 AÑOS	68	8
40-49 AÑOS	24	3
50-59 AÑOS	7	1
10-19 AÑOS	8	
60-69 AÑOS	3	
70-79 AÑOS		
0-9 AÑOS		

80-89 AÑOS		
TOTAL	**167**	**26**

Fuente: Base de datos VIH-UVS

En el año 2025 prevalece el grupo de 20-29 años con 57 casos, seguido por el grupo de 30-39 años con 68 casos, en el grupo de 40-49 años con 24 casos y el grupo con menor casos nuevos es de 50-59 años con 7 casos, 10-19 años con 8 casos y de 60-69 años con 3 casos.

Figura1 casos VIH positivos según edad y sexo RSM-DC.2026



Fuente: Base de datos VIH-UVS

Los casos de VIH notificados en 2026 según sexo y grupo de edad muestran predominio del sexo masculino, que representa un 88% de los casos, mientras que el sexo femenino corresponde al 12%, evidenciando una mayor afectación en hombres. En cuanto a la distribución por edad, la mayor concentración de casos se observa en los grupos de 25 a 29 años y 20 a 24 años, seguidos por los grupos de 30 a 34 años y 35 a 39 años, lo que indica que la infección se presenta principalmente en población joven y adultos jóvenes en edad sexualmente activa.

Tabla 2. Casos de VIH según identidad de género RSM-DC año 2025-2026

ORIENTACION SEXUAL	2025	2026
BISEXUAL	36	5

HETEROSEXUAL	66	8
HOMOSEXUAL	57	13
OTROS	8	
TRANSEXUAL		
TOTAL	**167**	**26**

Fuente: Base de datos VIH-UVS

Los datos de orientación sexual años 2025 y 2026, se observa una distribución de casos distinta entre los grupos. En 2025, el grupo homosexuales siendo con el 34% de los casos, seguido por los grupos heterosexual (39%) siendo el grupo mayoritario y bisexuales (22%) en el grupo transexual hubo 0 casos.
En el 2026 prevalece el grupo de homosexual (50%), le sigue el grupo heterosexual (31%) y por último el grupo bisexual (19%).

Tabla 3. Casos de VIH según población clave RSM-DC año 2025-2026

POBLACION CLAVE	TAMIZAJE ENERO FEB 2026	POSITIVOS	% POSITIVIDAD
HSH	451	16	4%
TRANS	22	0	0%
TRABAJADOR SEXUAL	142	0	0%
POBLACION GENERAL	2829	15	1%
EMBARAZADA	1942	0	0%

Fuente: Base de datos USLAB

La positividad de VIH según población clave para el período enero–febrero de 2026 muestra que los hombres que tienen sexo con hombres (HSH) presentan la mayor positividad con 4% (16 casos de 451 pruebas), evidenciando una mayor concentración de la infección en este grupo. La población general mantiene una positividad de 1% (15 de 2,829 pruebas), lo que indica transmisión a nivel comunitario, aunque en menor proporción. Por su parte, las poblaciones trans, trabajadores sexuales y mujeres embarazadas no reportan casos positivos en el período analizado (0%)

Tabla 4. Distribución de casos VIH según escolaridad RSM-DC año 2025 -2026

ESCOLARIDAD	2025	2026	Total
UNIVERSIDAD COMPLETA	39	9	48
SECUNDARIA COMPLETA	38	4	42
NC	28	2	30
UNIVERSIDAD INCOMPLETA	21	3	24
PRIMARIA COMPLETA	16	4	20
PRIMARIA INCOMPLETA	15		15
SECUNDARIA INCOMPLETA	10	3	13
NINGUNO		1	1
Total	**167**	**26**	**193**

Fuente: Base de datos UVS

La distribución de casos de VIH según nivel educativo evidencia un mayor número de casos en personas con universidad completa (48 casos) y secundaria completa (42 casos), lo que indica que la infección se presenta en poblaciones con niveles educativos medios y altos, descartando una asociación exclusiva con baja escolaridad.

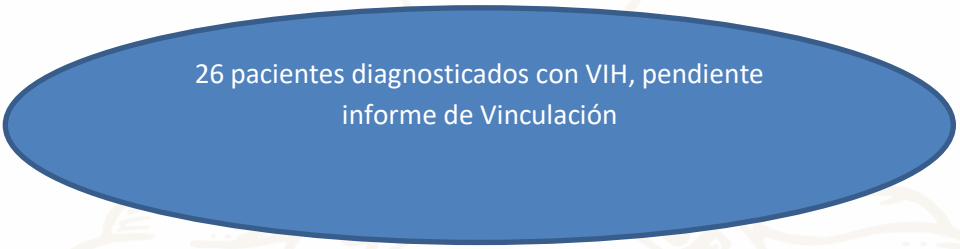
Figura 2. Mapa de Distribución de casos VIH positivo según establecimiento de salud RSM-MDC. 2026

Fuente: Base de datos UVS

El CIS Alonso Suazo concentra la mayor carga con 9 casos, representando el 34.6% del total, seguida por San Miguel con 4 casos (15.4%) y Villa Adela con 3 casos (11.5%). Un segundo grupo de colonias presenta una frecuencia intermedia: Carrizal, Las Crucitas, Flor Del

Campo cada una con 2 casos (7.7%). Finalmente, las colonias 21 De febrero, El Edén , Manchén y Nueva Esperanza reportan 1 caso cada una (3.8% cada una),

Figura 3. Casos VIH positivos y Vinculaciones RSM-DC



Información preliminar datos sujetos ajuste al actualizar base de vinculaciones

Tabla 5. Distribución de casos positivos por VIH según notificante RSM-DC año 2026

NOTIFICANTE	2026
KUKULCAN	6
INCP	4
ALONSO SUAZO	4
HOSPITAL ESCUELA	3
ESPECIALIDADES IHSS	2
ASHONPLAFA	2
PEDREGAL	1
PASMO	1
MANCHEN	1

Fuente: Base de datos VIH-UVS

El mayor notificante de casos VIH positivo es Kukulcán con 6 casos (23%), seguido por el Alonzo Suazo y INCP con 4 casos (15%), HEU con 3 casos (12%), el IHSS y Ashonplafa con 2 casos r (8%), el Pedregal, Manchen y Pasmo tienen 1 caso (4%).

Tabla 6. Mortalidad por VIH RSM-DC. 2026

NOTIFICANTE	TOTAL
HE	1
IHSS	1
INCP	
TOTAL	

Fuente: Base datos HE, INCP, IHSS

Nota: Los datos sujetos a cambio según ingreso de bases por los hospitales

Tasa de mortalidad 2025: **1.5** (30/1357,750x100,000 Hab)

Tasa de Mortalidad 2026: **0.14** (2/1,372705x100,000 Hab)

Tabla 7. Casos de coinfección TB/VIH en la RSM-DC. 2025

Año	Población	Positivos TB	Coifeccion- TB-VIH	Incidencia VIH/TB	Positividad TB/VIH
2025	1,357,756	275	12	0.88	4%
2026	1,372,705	30	2	0.15	7%

Fuente: Base de datos Tuberculosis AGI.

En el año 2025 se registraron 275 casos de tuberculosis (TB), de los cuales 12 presentaron coinfección TB/VIH (incluyendo 1 diagnóstico conocido de VIH), lo que representa una positividad de 4 % de VIH entre los casos de TB. Del total de personas con VIH notificadas (167), el 7% desarrolló TB, evidenciando la estrecha relación entre ambas enfermedades y el impacto del VIH en la progresión a TB activa. La incidencia poblacional de la coinfección TB/VIH es de 0.88 casos por 100,000 habitantes (12/1,357,756), lo que indica una carga baja en términos poblacionales, pero epidemiológicamente relevante por su gravedad clínica.

Para 2026, se reportan 30 casos de TB y 2 coinfecciones, evidenciando una incidencia de TB/VIH de 0.15 por 100,000 habitantes (2/1,372,705 × 100,000). La positividad VIH/TB es

6.67% (2/30), indicando que, aunque hay menos casos absolutos, el peso relativo del VIH entre los casos de TB es mayor.

Nota: La información se actualiza según los casos notificados en la AGI

Tabla 8. Embarazadas VIH positivo RSM-DC 2025-2026

Embarazadas	Total
Notificadas	16
DX nuevos	6
Dx conocidos	10
Vinculadas	16
Iniciaron TAR	6
Transmisión vertical	0

Fuente: Base de embarazadas AGI

En 2025 se notificaron 16 embarazadas con VIH, de las cuales 6 correspondieron a diagnósticos nuevos y 10 ya conocían su estado serológico; la totalidad fue vinculada a atención e inició o continuó terapia antirretroviral (TAR), alcanzando una cobertura del 100% de tratamiento en gestantes. No se registraron eventos de transmisión vertical, lo que evidencia la efectividad del abordaje programático y clínico en la prevención de la transmisión materno infantil.

En el 2026 no se han notificados casos

Recomendaciones

1. Fortalecer la captación de nuevos casos, con énfasis en la población vulnerable, garantizando la vinculación y adherencia al tratamiento.

2. Dar cumplimiento a las fechas establecidas para el envío de informes, ya que su retraso dificulta el análisis oportuno.

3. Se sugiere a las diferentes unidades y departamentos de la RSM-DC dar cumplimiento a la normativa con respecto a la evaluación, monitoreo y seguimiento de cada uno de los casos de los pacientes positivos por VIH.

4. Dar seguimiento a los resultados de la normativa vinculando los incumplimientos encontrados, con la unidad de vigilancia de marco normativo con el propósito de dar cumplimientos a los indicadores 95-95-95.

5. Realizar el seguimiento de los Recién Nacidos de madres VIH positivos para evaluar la eficacia de los programas de prevención de la transmisión vertical del VIH, facilitando mejoras continuas, y la detección temprana de la infección en el neonato, lo cual es fundamental para iniciar el tratamiento antirretroviral (TAR) de inmediato, mejorando las perspectivas de salud y longevidad del niño.

6. Fortalecer la promoción y prevención en Salud con respecto a la educación sexual y uso de condón.

7. Establecer un sistema de seguimiento y recordatorios mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto o aplicaciones móviles, para asegurar que las mujeres embarazadas regresen para las segundas muestras y sigan el protocolo completo de tamizaje.

8. Focalizar esfuerzos de prevención y tratamiento en los grupos de mayor riesgo, como los HSH y aquellos con coinfección TB/VIH, asegurando acceso a recursos y servicios específicos para estas poblaciones.